

1. Introducción y relevancia clínica

La **visión de halos** y las **fotopsias (destellos luminosos)** son síntomas visuales frecuentes que pueden tener **causas benignas o representar emergencias oftalmológicas**.

Su correcta interpretación permite diferenciar patologías **corneales o refractivas** de **procesos graves como el desprendimiento de retina o el glaucoma agudo de ángulo cerrado**.

Definiciones

- **Halos:** percepción de anillos de colores alrededor de luces, especialmente en la oscuridad o durante la noche.
- **Fotopsias:** sensación de destellos o relámpagos visuales sin estímulo luminoso real, producto de tracción mecánica o irritación retiniana.

Relevancia clínica

- En el contexto de urgencias, estos síntomas orientan a causas **estructurales o fisiológicas específicas**.
- Su diagnóstico precoz puede **prevenir la pérdida visual permanente**, especialmente en el **desprendimiento de retina o el glaucoma agudo**.
- En el **EUNACOM**, las fotopsias suelen presentarse en preguntas sobre “luces y sombras en cortina”, mientras que los **halos** son clave en el diagnóstico de **glaucoma agudo de ángulo cerrado**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiopatología de los halos

Los **halos** se originan por **dispersión anormal de la luz** antes de que llegue a la retina, habitualmente por:

- **Edema corneal** (glaucoma agudo, queratitis).
- **Irregularidades en la superficie corneal** (uso de lentes de contacto, distrofias).
- **Catarata incipiente** (difracción por opacidades del cristalino).
- **Medios ópticos turbios** (aumento de lágrimas o secreciones).

Mecanismo óptico: la luz se dispersa en forma de anillo circular coloreado debido a interferencias difractivas.

2.2 Fisiopatología de las fotopsias

Las **fotopsias** corresponden a **fenómenos visuales secundarios a estimulación mecánica o eléctrica de la retina**.

Su causa más habitual es la **tracción vítreo-retiniana**, donde el humor vítreo, al colapsar con la edad, **tira de la retina**, activando los fotorreceptores.

Otras causas:

- **Desprendimiento de vítreo posterior.**
 - **Desgarro o desprendimiento de retina.**
 - **Migraña ocular (escotomas centelleantes).**
 - **Compresión o isquemia del nervio óptico o retina.**
-

2.3 Clasificación fisiopatológica

Tipo de síntoma	Origen anatómico	Ejemplos clínicos
Halos	Córnea / cristalino	Glaucoma agudo, catarata, edema corneal
Fotopsias	Retina / vítreo / corteza visual	Desprendimiento de retina, vítreo posterior, migraña ocular

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Halos

Características clínicas:

- Halos multicolores alrededor de luces.
- Empeoran de noche o con iluminación artificial.
- Pueden asociarse a **visión borrosa, dolor ocular o cefalea** (en glaucoma agudo).
- En casos crónicos (catarata), la visión se deteriora lentamente y sin dolor.

Principales causas:

Etiología	Características asociadas	Dolor	Pérdida visual
Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Halos + dolor intenso + náuseas	Sí	Súbita
Catarata incipiente	Halos nocturnos sin dolor	No	Progresiva
Edema corneal (queratitis, trauma)	Ojo rojo, fotofobia	Variabl e	Variable
Uso de lentes de contacto / lágrimas excesivas	Transitorio	No	No

3.2 Fotopsias

Características clínicas:

- Destellos, luces intermitentes o relámpagos, especialmente en la oscuridad.

- Sensación de “moscas volantes” (miodesopsias).
- Pérdida de campo visual en forma de “cortina oscura” → **signo de desprendimiento de retina.**

Principales causas:

Etiología	Características asociadas	Dolor	Pérdida visual
Desprendimiento de vítreo posterior	Fotopsias aisladas, sin pérdida visual	No	No
Desgarro / desprendimiento de retina	Fotopsias + sombra o cortina visual	No	Sí
Migraña ocular	Escotomas centelleantes bilaterales + cefalea pulsátil	No	Transitoria
Isquemia retiniana transitoria	Fotopsias + amaurosis fugaz	No	Reversible
Compresión del nervio óptico / tumores	Fotopsias focales	No	Progresiva

3.3 Diagnóstico diferencial global

Síntoma principal	Diagnóstico probable	Características diferenciales
Halos + dolor + náuseas	Glaucoma agudo	Pupila media fija, córnea opaca

Halos sin dolor	Catarata o irregularidad corneal	Progresivo
Fotopsias + miodesopsias	Desprendimiento vítreo o retiniano	Flotadores y destellos
Fotopsias bilaterales + cefalea	Migraña ocular	Autolimitado

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial (APS o urgencia)

1. **Agudeza visual monocular.**

↓ visión → requiere derivación urgente.

2. **Inspección externa:**

- Ojo rojo, edema corneal, pupila anómala → glaucoma agudo.

3. **Reflejo pupilar directo y consensual.**

4. **Biomicroscopía o tinción con fluoresceína** (si sospecha de queratitis).

5. **Tonometría (si disponible):**

- PIO > 40 mmHg → diagnóstico de glaucoma agudo.

6. **Fondo de ojo directo:**

- Retina flotante o pliegues → desprendimiento.
 - Retina normal pero visión de luces → desprendimiento vítreo.
-

4.2 En nivel especializado (oftalmología)

Examen	Utilidad
OCT (tomografía de coherencia óptica)	Evalúa retina y mácula.
Ecografía ocular modo B	Diagnóstico de desprendimiento de retina o hemorragia vítrea.
Gonioscopia	Valora ángulo camerular en glaucoma.
Biomicroscopía con lámpara de hendidura	Detecta edema corneal, catarata o queratitis.
Campimetría visual	Valora daño glaucomatoso o cortical.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Principio general

El tratamiento depende de la causa subyacente y debe priorizar la **preservación de la función visual** y la **derivación urgente** cuando corresponde.

5.2 Conducta por patología principal

A. Glaucoma agudo de ángulo cerrado

Emergencia oftalmológica.

- Dolor ocular severo, halos, visión borrosa, pupila fija, náuseas.

Tratamiento:

1. **Acetazolamida 500 mg EV o VO.**

2. **Manitol 20% EV 1 g/kg.**
 3. **Colirios: timolol, brimonidina, pilocarpina.**
 4. Analgésicos y antieméticos.
 5. **Derivación inmediata a oftalmología para iridotomía láser bilateral.**
-

B. Desprendimiento de retina

Signos: Fotopsias, miodesopsias, “cortina oscura”.

Tratamiento:

- **Derivación urgente a oftalmología.**
 - Evitar movimientos bruscos.
 - Cirugía correctiva (retinopexia o vitrectomía).
 - Pronóstico favorable si mácula no afectada.
-

C. Desprendimiento vítreo posterior

- Común en mayores de 50 años.
- Generalmente benigno, pero requiere fondo de ojo para descartar desgarro retiniano.

Conducta:

- **Observación y control oftalmológico** en 1–2 semanas.
 - Indicar signos de alarma (aumento de fotopsias o sombra visual).
-

D. Migraña ocular

- Escotomas centelleantes bilaterales, reversibles.

Tratamiento:

- Reposo, analgesia y manejo preventivo antimigrañoso si recurrente.
 - No requiere derivación urgente si se descarta patología ocular.
-

E. Catarata

- Halos sin dolor ni pérdida súbita.

Tratamiento:

- Control oftalmológico electivo.
 - **Cirugía de facoemulsificación** según indicación visual.
-

F. Edema corneal (queratitis o trauma)

- Halos + ojo rojo + dolor.

Tratamiento:

- Antibióticos tópicos si sospecha infección.
 - Suspender lentes de contacto.
 - Derivar si disminuye visión.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Patología	Complicación	Pronóstico
Glaucoma agudo	Daño irreversible del nervio óptico	Grave si no tratado precozmente
Desprendimiento de retina	Ceguera permanente	Bueno si cirugía precoz

Desgarro retiniano no tratado	Desprendimiento completo	Variable
Desprendimiento vítreo posterior	Desgarro retiniano secundario	Bueno con control
Migraña ocular	Confusión diagnóstica	Benigno
Catarata	Pérdida visual progresiva	Excelente con cirugía

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Halos + dolor + náuseas** → **glaucoma agudo** hasta demostrar lo contrario.
 2. **Fotopsias + sombra en cortina** → **desprendimiento de retina** (derivación urgente).
 3. **Fotopsias aisladas sin pérdida visual** → **desprendimiento vítreo posterior**.
 4. **Migraña ocular** → **síntomas bilaterales, reversibles, sin hallazgos oftálmicos**.
 5. **Catarata** → **halos sin dolor, visión progresivamente borrosa**.
 6. Siempre realizar **fondo de ojo** en fotopsias persistentes.
 7. En glaucoma agudo, **no dilatar la pupila** ni usar corticoides tópicos.
-

Errores comunes

- Tratar halos como “conjuntivitis” sin evaluar presión intraocular.
- No derivar al oftalmólogo ante fotopsias persistentes o pérdida visual parcial.

- Omitir fondo de ojo en pacientes con “moscas volantes”.
 - No sospechar glaucoma agudo ante dolor ocular con visión borrosa.
 - No informar al paciente sobre signos de alarma (aumento de luces o cortina visual).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Halos** se originan por **edema corneal o catarata**, y **fotopsias** por **estimulación retiniana o vítrea**.
2. **Glaucoma agudo** es la causa más grave de halos: dolor, pupila fija, náuseas → **emergencia oftalmológica**.
3. **Fotopsias + cortina visual** indican **desprendimiento de retina** → cirugía urgente.
4. **Desprendimiento vítreo posterior** causa fotopsias benignas pero requiere control.
5. **Migraña ocular** causa destellos bilaterales transitorios sin daño visual.
6. Todo paciente con **fotopsias, pérdida visual o dolor ocular intenso** debe ser **derivado inmediatamente**.
7. La **evaluación inicial** siempre debe incluir **agudeza visual, pupilas, PIO y fondo de ojo**.